

Subsecretaría de Redes Asistenciales
Departamento de Control de Gestión
GER/VDB/EGE/ELP/YMB/FPD/GRA



7

FIJA METAS SANITARIAS NACIONALES Y OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PROPORCIONADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL AÑO 2026, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DFL N° 1, DE 2005, DEL MINISTERIO DE SALUD

EXENTA N° 649 /

SANTIAGO, 09 SEP 2025

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°18.933 y N°18.469; en la Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el Decreto Supremo N°136, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el Decreto Supremo N°123, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento que regula el otorgamiento del componente asociado al cumplimiento anual de metas sanitarias y mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de las asignaciones de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, y de acreditación individual y estímulo al desempeño colectivo, conforme a lo señalado los artículos 63 y 67 del Decreto Ley N° 2.763 de 1979; y lo dispuesto en la resolución N°36 del 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón y;

CONSIDERANDO:

1. Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.
2. Qué, asimismo, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles.
3. Que, el título II, del Capítulo VI, denominado "De las plantas de personal y otras disposiciones generales", del Libro I, de la Organismo Públicos de Salud, del DFL N°1, del 2005, antes citado, contempla una asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo para el personal perteneciente a las plantas de auxiliares, técnicos y administrativos, sea de planta o a contrata de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del DFL N°1, de 2005, ya mencionado, regidos por la ley N°18.834, la que contendrá un componente base y otro variable asociado al cumplimiento anual de metas sanitarias y al mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de los organismos señalados.
4. Que, para efectos de otorgar el componente variable de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, el Ministerio de Salud fijará las metas sanitarias nacionales para el año siguiente y los objetivos de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de cada uno de los Servicios de Salud. Las metas sanitarias y las de mejoramiento de la atención, serán establecidas mediante resolución del Subsecretario de Redes Asistenciales. Para estos efectos,

deberán considerarse las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los objetivos globales o compromisos que deberán cumplirse durante el año calendario siguiente por los Servicios de Salud.

5. Que, en conformidad a lo anterior, el Director de cada Servicio de Salud determinará para cada uno de sus establecimientos, incluida la Dirección del Servicio, las metas específicas y los indicadores de actividad.
6. Que, se torna necesario, en virtud de las disposiciones antes citadas, dictar el acto administrativo que fije las metas sanitarias nacionales para el 2026 y los objetivos de mejoramiento de la atención.
7. Que, conforme al mérito de lo enunciado, procedo a dictar lo siguiente:

RESOLUCIÓN

1º FÍJASE para el año 2026, las metas sanitarias nacionales y los objetivos de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios de los Servicios de Salud, que a continuación se indican:

I. Objetivos de Mejoramiento de la Atención de la Gestión para el año 2026, correspondientes a los Servicios de Salud y Establecimientos de la Red Asistencial.

1. Mejorar el nivel de salud de la población, anticipándose a los problemas sanitarios mediante estrategias de promoción y prevención, y garantizar una atención médica oportuna y de calidad cuando ésta se requiera:
 - a. Reducir la prevalencia de aquellas enfermedades prevenibles a través del control de sus factores de riesgo.
 - b. Contribuir a satisfacer las necesidades de atención médica de la población y procurar una atención resolutive.
 - c. Mejorar la calidad de la atención, de la actividad quirúrgica y de hospitalización en los establecimientos de los Servicios de Salud, por medio de la revisión permanente de prácticas de trabajo, prevención, control y eficacia en el uso de los recursos.
2. Mejorar las intervenciones clínicas, especialmente en áreas de apoyo diagnóstico y clínico terapéutico, para entregar una mejor calidad en los servicios asistenciales.
3. Fortalecer la coordinación, el desarrollo y gestión de la red asistencial de los Servicios de Salud y cumplir el Régimen de Garantías en Salud conforme a la legislación vigente en la materia.
4. Fortalecer las competencias laborales en los ámbitos del nuevo modelo de atención, sistema de garantías en salud, calidad de la atención, trato al usuario y/o mejoramiento de la gestión de la red asistencial.

II.

Metas Sanitarias para el año 2026 correspondientes a los Servicios de Salud y Establecimientos de la Red Asistencial.

1. Metas Sanitarias de Establecimientos de Alta, Mediana y Baja Complejidad de la Red de Servicios de Salud.

Numero de indicador	1
Nombre del Indicador	Lactancia Materna Exclusiva en niños y niñas al sexto mes de vida
Objetivo del indicador	Promocionar y aumentar los factores protectores de salud, capaces de retrasar el desenlace de ENTs y aumentar el porcentaje de normalidad del estado nutricional en niños y niñas menores de 6 años.
Meta anual	Alcanzar al menos el 60,00%
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 1 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficiencia
Fórmula de Cálculo	(Número de niños y niñas controlados en el período de enero a diciembre de 2026 que al control de salud del sexto mes recibieron LME / Número de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado en el período de enero a diciembre de 2026) *100
Fuente de información del Numerador	REM
Fuente de información del Denominador	REM
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimiento de APS dependiente y Hospitales de baja complejidad que tengan APS
Exclusiones	N/A
Definición de términos	LME: Lactancia Materna Exclusiva
División que lo monitorea	DIVAP

Numero de indicador	2
Nombre del Indicador	Cobertura de exámenes de detección precoz del cáncer de cuello uterino
Objetivo del indicador	Monitorear cobertura y productividad de exámenes de tamizajes
Meta anual	Reducir la brecha en un 30% para cumplir el 80% de cobertura
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 1 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficiencia
Fórmula de Cálculo	(Número de mujeres y personas TRANS masculinos de 25 a 64 años adscritas, con PAP o Test de VPH vigente a diciembre 2026 / Número de mujeres y personas TRANS masculinos de 25 a 64 años, adscritas para el año 2026) *100
Fuente de información del Numerador	REM
Fuente de información del Denominador	FONASA - Población adscrita (mujeres y transmasculinos) debe ser provisto por el establecimiento al momento de la fijación de la meta
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimiento de APS dependiente y Hospitales de baja complejidad que tengan APS.
Exclusiones	N/A
Definición de términos	Población Adscrita: La población adscrita corresponde a los usuarios inscritos o asignados a establecimientos dependientes de Servicios de Salud. VPH: Virus Papiloma Humano PAP: Papanicolaou
División que lo monitorea	DIVAP

Numero de indicador	3
Nombre del Indicador	Personas con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) compensadas
Objetivo del indicador	Aumentar la compensación de las personas de 15 y más años, con DM2 bajo control
Meta anual	50,00%



Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 1 del Formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado intermedio
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número de personas con DM2 de 15 y más años compensadas/Número de personas con DM2 de 15 y más años bajo control) *100
Fuente de información del Numerador	REM
Fuente de información del Denominador	REM
Número de decimales	2 decimales, con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimiento de APS dependiente y Hospitales de baja complejidad que tengan APS.
Exclusiones	N/A
Definición de términos	Personas bajo control por Diabetes Mellitus tipo 2 compensadas: corresponde a las personas que se encuentran en control con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, y con valores de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) según lo siguiente: DIABETES MELLITUS TIPO 2 de 15 a 79 años HbA1c <7% 80 y más años HbA1c <8%
División que lo monitorea	DIVAP

Numero de indicador	4
Nombre del Indicador	Personas con Hipertensión Arterial (HTA) compensadas
Objetivo del indicador	Aumentar la compensación de las personas de 15 y más años con HTA bajo control
Meta anual	71,00%
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Mediana
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 1 del Formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado intermedio
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número de personas con HTA de 15 y más años compensadas/Número de personas con HTA de 15 y más años bajo control) *100
Fuente de información del Numerador	REM
Fuente de información del Denominador	REM
Número de decimales	2 decimales, con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimiento de APS dependiente y Hospitales de baja complejidad que tengan APS.
Exclusiones	N/A
Definición de términos	Personas bajo control por Hipertensión Arterial compensada: Corresponde a las personas que se encuentran en control con diagnóstico de Hipertensión Arterial con control de la presión arterial a la fecha del corte, según lo siguiente: HIPERTENSIÓN ARTERIAL de 15 a 79 años PA < 140/90 mm Hg 80 y más años PA < 150/90 mm Hg
División que lo monitorea	DIVAP

Numero de indicador	5
Nombre del Indicador	Pacientes con indicación de hospitalización desde Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH), que acceden a cama de dotación en menos de 12 horas
Objetivo del indicador	Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos
Meta anual	≥ 85,00%
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 2 y 5 del Formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número total de pacientes con indicación de hospitalización que espera en UEH en un tiempo menor a 12 horas para acceder a cama de dotación / Número total de pacientes con indicación de hospitalización en UEH) *100
Fuente de información del Numerador	REM
Fuente de información del Denominador	REM

Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Trimestral
Nivel de aplicación	Establecimientos con UEH que realizan hospitalizaciones adulto y/o pediátricas
Exclusiones	Pacientes que acceden directamente al proceso quirúrgico. Urgencias Obstétricas.
Definición de términos	Pacientes con indicación de hospitalización: Son aquellos pacientes en quienes el profesional Médico decide que debe acceder a una cama hospitalaria o cupo de hospitalización domiciliaria para recibir en forma inmediata atención médica, ya sea diagnóstica o terapéutica, pues de no mediar esta situación, él puede sufrir daño permanente. Esto es independiente si el paciente espera en camilla, silla u otros. Lo importante es la indicación de hospitalización.
División que lo monitorea	DIGERA

Numero de indicador	6
Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de Garantías Explícitas en Salud (GES) en la Red
Objetivo del indicador	Gestionar la demanda asistencial facilitando el acceso y la oportunidad en la atención
Meta anual	Cumple con un 100% si obtiene un resultado del indicador ≥ 99,50%
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 1 y 2 del formulario A1 de la subsecretaria de Redes Asistenciales. Objetivo 1 y 3 del formulario A1 de los Servicios de Salud.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado final
Dimensión que aborda	Eficiencia
Fórmula de Cálculo	((Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas) en el año t / (Garantías Cumplidas + Garantías Exceptuadas + Garantías Incumplidas Atendidas + Garantías Incumplidas No Atendidas) en el año t + Garantías Retrasadas acumuladas)) *100
Fuente de información del Numerador	SIGGES
Fuente de información del Denominador	SIGGES
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Anual
Nivel de aplicación	Establecimientos de Salud
Exclusiones	Quedan excluidos los establecimientos que no suscriben este instrumento de evaluación de Metas Sanitarias
Definición de términos	Garantías Cumplidas: En esta agrupación se consideran las garantías realizadas dentro del plazo máximo que señala el decreto. Garantías Exceptuadas: podrán exceptuarse de dar cumplimiento a una garantía de oportunidad (Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, Superintendencia de Salud), cuando por causa imputable al beneficiario o por fuerza mayor derivada de su estado de salud, sea imposible otorgar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso. Garantías Incumplidas Atendidas: es aquella garantía de oportunidad realizada fuera del plazo garantizado para cada problema de salud incluido en GES. Garantías Incumplida No atendida: El establecimiento no logró realizar la atención garantizada dentro de los tiempos establecidos, y es imposible entregarla en forma tardía por una condición o decisión del paciente. Garantías Retrasadas: Corresponde a aquellas que no evidencian en SIGGES una atención, ya sea por no registro de esta o por no realización de la prestación
División que lo monitorea	DIGERA

Numero de indicador	7
Nombre del Indicador	Disminución del exceso de días de estancias asociados a egresos con estancias prolongadas (outliers superiores)
Objetivo del indicador	Mejorar la eficiencia en el uso de recurso cama de los establecimientos de la Red Asistencial
Meta anual	Disminución de un 5% en el número de exceso de estancias asociados a outliers superiores, respecto del mismo periodo año previo, para hospitales con porcentaje de outliers superiores mayor o igual a 5,0% y para hospitales con porcentaje menor a 5 debe disminuir un 2.0%. Esto según base emitida desde el nivel central (fuente ALCOR GRD)
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 2 y 5 del Formulario A1 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado
Dimensión que aborda	Eficiencia



Fórmula de Cálculo	[(Exceso de estancias outliers superiores periodo t – exceso de estancias outliers superiores periodo t-1) / Exceso de estancias outliers superiores periodo t-1] * 100
Fuente de información del Numerador	GRD- ALCOR
Fuente de información del Denominador	GRD- ALCOR
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Anual
Nivel de aplicación	Establecimientos de alta y mediana complejidad
Exclusiones	Pacientes cuya especialidad médica es psiquiatría, judicializados CIE10 Z65.3. Problemas relacionados con otras circunstancias legales (arresto, custodia niño, procedimiento de amparo, juicio o litigio)
Definición de términos	Exceso de estancias outliers superiores: corresponde a la sumatoria de los días consumidos en exceso por cada caso con estancia prolongada.
División que lo monitorea	DIGERA

Numero de indicador	8
Nombre del Indicador	Ejecución del Plan Anual de mantenimiento preventivo de equipos médicos, ambulancias, equipos industriales, infraestructura y ejecución del gasto respecto al presupuesto asignado
Objetivo del indicador	Optimizar los procesos críticos que impacten en el buen uso de recursos a través de la mantención preventiva de equipos médicos, ambulancias, equipos industriales, infraestructura y ejecución del gasto respecto al presupuesto asignado.
Meta anual	≥ 90,00%
Responsable de la gestión	Subdirección Administrativa – Unidad de Operaciones
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 4 del Formulario A1 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	$((N^{\circ} \text{ de mantenciones ejecutadas de equipos médicos} / N^{\circ} \text{ de mantenciones programadas de equipos médicos}) * 0,2) + ((N^{\circ} \text{ de mantenciones ejecutadas de equipos industriales} / N^{\circ} \text{ de mantenciones programadas de equipos industriales}) * 0,2) + ((N^{\circ} \text{ de mantenciones ejecutadas de ambulancias} / N^{\circ} \text{ de mantenciones programadas de ambulancias}) * 0,2) + ((N^{\circ} \text{ de mantenciones ejecutadas de infraestructura} / N^{\circ} \text{ de mantenciones programadas de infraestructura}) * 0,2) + ((\text{Ejecución en SIGFE del plan de mantenimiento preventivo de equipos médicos, equipos industriales, infraestructura y ambulancias} / \text{programación presupuestaria de mantenimiento preventivo de equipos médicos, equipos industriales, infraestructura y ambulancias}) * 0,2) * 100$
Fuente de información del Numerador	Local
Fuente de información del Denominador	Local
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Todos los establecimientos dependientes de los Servicios de Salud
Exclusiones	Activos que se encuentran en reparación o en servicio técnico por un tiempo prolongado (mayor a 1 mes) o que hayan sido dados de baja durante el periodo.
Definición de términos	Equipo médico: Equipo eléctrico, provisto de una sola conexión con la red de alimentación o batería y destinado a diagnosticar, tratar o vigilar al paciente bajo supervisión médica y que tiene contacto físico o eléctrico con el paciente y transfiere o recibe energía al o del mismo, o detecta dicha energía transferida o recibida al o del paciente. El equipo incluye aquellos accesorios que se definen por el fabricante como necesarios para permitir la utilización normal del equipo. Equipo industrial: Corresponde al equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas y subsistemas del edificio del establecimiento de atención de salud, se considerará para todos los efectos formando parte de la infraestructura Infraestructura: Es toda la obra material y física construida con sus redes de instalaciones y equipos industriales, dentro de la cual funciona el establecimiento de atención de salud. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza para prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir desperfectos. El Mantenimiento Preventivo habitualmente se programa a intervalos definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza o reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil limitada. Por lo general es el fabricante el que establece los procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede modificar la frecuencia de acuerdo con las condiciones del medio local (Metodología de Fennigkon y Smith).
División que lo monitorea	INVERSIONES

2. Metas sanitarias y de mejoramiento de la gestión 2026 servicio de atención médica de urgencia (SAMU), que cuente con centro reguladores SAMU.

Número del indicador	9
Nombre del Indicador	Llamadas al 131 contestadas en menos de 10 segundos
Objetivo del indicador	Velar por la oportunidad en la atención telefónica en los Centros de Atención Prehospitalaria, optimizando el tiempo de respuesta de llamados realizados por la población.
Meta anual	≥ 90,00%
Responsable de la gestión	Establecimiento de Salud
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 3 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado final
Dimensión que aborda	Calidad
Fórmula de Cálculo	(Número de llamadas al 131 contestadas en menos de 10 segundos / (Número de llamadas totales entrantes a 131 - número de llamadas abandonadas por el usuario antes de 3 segundos de espera)) *100
Fuente de información del Numerador	Distribuidor automático de llamadas (ACD)
Fuente de información del Denominador	Distribuidor automático de llamadas (ACD)
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Trimestral
Nivel de aplicación	Centros Regulador SAMU
Exclusiones	No aplica a establecimientos de salud hospitalario
Definición de términos	Llamada entrante: llamada iniciada por el solicitante y dirigida al Centro Regulador SAMU, que tenga una duración en cola de al menos 3 segundos. Llamada contestada: llamada que ha sido respondida por un operador telefónico y se establece o no una comunicación bidireccional. Para la contabilización de llamadas se deberá descontar las llamadas ghost. Llamada abandonada antes de 3 segundos (Ghost): es una llamada que ingresa al Centro Regulador y es abandonada antes de los primeros 3 segundos.
División que lo monitorea	DIGERA

Numero de indicador	10
Nombre del Indicador	Llamados telefónicos de emergencia 131 por Paro cardio respiratorio (PCR) con entrega de instrucciones de Soporte Vital Básico a testigos o solicitante
Objetivo del indicador	Entregar instrucciones de soporte vital básico a testigos ante eventos de paro cardio respiratorio.
Meta anual	≥ 95,00%
Responsable de la gestión	Establecimiento de Salud
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 2 y 5 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado final
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número de llamados telefónicos con instrucciones de soporte vital básico entregadas a testigos en caso de PCR / Total de llamados telefónicos de atención de pacientes por PCR) *100
Fuente de información del Numerador	Sistema de información del Centro Regulador
Fuente de información del Denominador	Sistema de información del Centro Regulador
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Trimestral
Nivel de aplicación	Centros Regulador SAMU
Exclusiones	No aplica a establecimientos de salud hospitalario
Definición de términos	PCR: Paro Cardiorrespiratorio Instrucciones Soporte Vital básico Telefónico: son indicaciones verbales proporcionadas por un operador (personal no médico), supervisor o médico regulador a través de una llamada telefónica, dirigidas a los testigos o solicitantes presentes en la escena de un paro cardio respiratorio (PCR)
División que lo monitorea	DIGERA

Numero de indicador	11
Nombre del Indicador	Disponibilidad Operativa de Call Takers SAMU
Objetivo del indicador	Monitorear la disponibilidad y conectividad de los operadores telefónicos (call takers), asegurando que siempre haya suficiente personal capacitado y conectado para atender de manera eficiente y oportuna todas las llamadas entrantes durante su turno.
Meta anual	65,00%
Responsable de la gestión	Centro Regulador SAMU
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 2 y 5 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficiencia
Fórmula de Cálculo	((Minutos totales del turno –minutos en pausa, modo auxiliar o desconectado) / Minutos totales del turno) *100
Fuente de información del Numerador	Distribuidor Automático de Llamadas ACD
Fuente de información del Denominador	Distribuidor Automático de Llamadas ACD
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Centros Regulador SAMU
Exclusiones	No aplica a establecimientos de salud hospitalario.
Definición de términos	Disponibilidad Operativa de Call Takers SAMU: Se refiere al porcentaje de call takers habilitados y conectados en comparación con el total de Call Taker programados. Este indicador mide la capacidad operativa y la eficiencia de los recursos humanos para atender llamadas de emergencia. Call Takers: Son los operadores que responden las llamadas de emergencia en el centro regulador del SAMU. Su función principal es recibir, procesar y coordinar las solicitudes de emergencia, asegurando una respuesta rápida y adecuada. Call Takers Habilitados: Son los operadores que están oficialmente asignados y programados para trabajar en un turno específico, habiendo cumplido con los requisitos necesarios para desempeñar sus funciones.
División que lo monitorea	DIGERA

3. Meta Sanitaria orientada a fortalecer las competencias laborales en los ámbitos del nuevo modelo de atención, sistema de garantías en salud, calidad de la atención y trato al usuario y mejoramiento de la gestión de la red asistencial

Número del indicador	12
Nombre del Indicador	Funcionarios/as capacitados/as en temáticas transversales relevantes
Objetivo del indicador	Fortalecer y actualizar conocimientos de los funcionarios/as en temáticas transversales relevantes en los Establecimientos de salud.
Meta anual	5% funcionarios/as de la dotación del personal capacitados en temáticas transversales relevantes.
Responsable de la gestión	Dirección del Establecimiento y Subdirección de Gestión de las Personas o Áreas de Recursos Humanos.
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 3 del Formulario A1 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número de funcionarios/as de la dotación del personal capacitados en temáticas transversales relevantes en el año t/ Número total de funcionarios/as de la dotación del personal del establecimiento de salud en el año t) *100
Fuente de información del Numerador	SIRH, considera corte de funcionarios en dotación de personal capacitado al 31 de diciembre de 2026.
Fuente de información del Denominador	SIRH, considera corte de funcionarios en dotación de personal al 31 de marzo de 2026.
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimientos dependientes de los Servicios de Salud
Exclusiones	Personal con contrato transitorio (reemplazo).

Definición de términos	Temáticas transversales relevantes: Se refiere a temáticas relacionadas a Trato Usuario, Humanización en la atención, DDHH, integridad y prevención en corrupción y violencia en espacios de trabajo (Probidad, transparencia). Funcionarios/as capacitados: funcionarios/as que aprobaron con nota mayor o igual a 4.0, una actividad de capacitación con una duración mínima de 20 horas pedagógicas. Funcionarios/as de la dotación del personal: funcionarios/as bajo Estatuto Administrativo Ley N°18.834, en calidad jurídica: titular, contrata y suplente.
División que lo monitorea	DIGEDEP.

Número del indicador	13
Nombre del Indicador	Funcionarios/as con capacitación actualizada en reanimación cardiopulmonar
Objetivo del indicador	Mantener con capacitación actualizada en reanimación cardiopulmonar a funcionarios/as de la dotación del personal.
Meta anual	60,00%
Responsable de la gestión	Dirección del Establecimiento y Subdirección de Gestión de las Personas o Áreas de Recursos Humanos.
Prioridad	Mediana
Objetivo estratégico asociado	Objetivos 3 del formulario A1 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Unidad de medida	Porcentual
Tipo de indicador	Proceso
Dimensión que aborda	Eficacia
Fórmula de Cálculo	(Número de Funcionarios/as de la dotación del personal con capacitación actualizada en reanimación cardiopulmonar / Número total de funcionarios/as de la dotación del personal) *100
Fuente de información del Numerador	SIRH, considera corte de funcionarios en dotación de personal, a diciembre del 2026, capacitado en reanimación cardiopulmonar entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2026.
Fuente de información del Denominador	SIRH, considera corte de funcionarios en dotación de personal al 31 de marzo de 2026.
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimientos dependientes de los Servicios de Salud
Exclusiones	Personal con contrato transitorio (reemplazo).
Definición de términos	Capacitación actualizada: curso aprobado con antigüedad menor a 5 años Reanimación cardiopulmonar: corresponde a la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas para la identificación y manejo básico o avanzado de paro cardiorrespiratorio. Funcionarios/as capacitados: funcionarios/as que aprobaron una actividad de capacitación. Funcionarios/as de la dotación del personal: funcionarios/as bajo Estatuto Administrativo Ley N°18.834, en calidad jurídica: titular, contrata y suplente.
División que lo monitorea	DIGEDEP

Numero de indicador	14
Nombre del Indicador	Cobertura de personal de salud con atención clínica directa capacitados en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud
Objetivo del indicador	Fortalecer y actualizar el conocimiento de personal de salud con atención clínica directa en las principales medidas de prevención y control de IAAS, con especial énfasis en precauciones estándares
Meta anual	70,00%
Responsable de la gestión	Dirección del establecimiento
Prioridad	Alta
Objetivo estratégico asociado	Objetivo 3 del Formulario A1 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Unidad de medida	Porcentaje
Tipo de indicador	Resultado final
Dimensión que aborda	Seguridad de la atención
Fórmula de Cálculo	(Número de personal de salud con atención clínica directa con curso de prevención y control de IAAS aprobado con antigüedad menor a 5 años / Número total de personal de salud con atención clínica directa) *100
Fuente de información del Numerador	SIRH
Fuente de información del Denominador	SIRH
Número de decimales	2 decimales con resultado truncado
Periodicidad de monitoreo	Semestral
Nivel de aplicación	Establecimientos de salud
Exclusiones	N/A
Definición de términos	Personal de salud de atención clínica directa: funcionarios que realiza ejercicio práctico de la atención de salud relacionado con la observación directa

	del paciente, su tratamiento y cuidados. Se excluyen funcionarios que realizan sólo actividades de carácter administrativo o actividades de apoyo, sin interacción directa con los pacientes. Curso de prevención y control de IAAS aprobado: Curso con duración mínima de 20 horas pedagógicas que al menos aborde precauciones estándares (higiene de manos, uso de equipo de protección personal prevención de lesiones cortopunzantes, inyecciones seguras, limpieza y desinfección de superficies, desinfección del alto nivel y esterilización de dispositivos médicos) y técnica aséptica, aprobado por el Programa de Control y Prevención de IAAS del establecimiento de salud.
División que lo monitorea	DIGERA

2°. **DETERMÍNESE** las metas específicas y los indicadores de actividad de cada establecimiento, de acuerdo con su nivel de complejidad y cartera de servicios, que deberán estar vinculados a los objetivos de mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios y a los productos relevantes de cada uno de ellos. En ningún caso las metas específicas del establecimiento podrán corresponder a materias que constituyen obligaciones de los funcionarios de conformidad a la ley N°18.834. No podrán definirse menos de cuatro metas para cada establecimiento.

3°. **INSTRÚYASE** a los Servicios de Salud que, durante el año 2025, hayan superado alguna de las metas de desempeño establecidas en este acto, a mantener al menos ese nivel alcanzado. Para los nuevos indicadores, deberán cumplir con las metas máximas fijadas en esta resolución. Si un Servicio de Salud necesita comprometer una meta inferior a la nacional, deberá justificarlo adecuadamente, sin mencionar problemas de gestión interna. En tal caso, la Subsecretaría de Redes Asistenciales decidirá si es pertinente aceptar una meta inferior a la nacional.

4°. **ESTABLÉZCASE** que los ponderadores para cada una de las metas de gestión, deberán tener una valorización mínima de un 10% y una máxima de 30%. En todo caso, la sumatoria de todos los ponderadores deberá totalizar 100%. Las ponderaciones deberán guardar relación con la relevancia de la meta para el establecimiento y el grado de dificultad de su cumplimiento. Para aplicar el ponderador correspondiente respecto de cada meta de gestión, deberá haberse cumplido al menos en un 60 %.

5°. **CONSIDÉRESE**, para efectos de esta resolución, que se entenderá por establecimiento las siguientes dependencias de los Servicios de Salud: Dirección del Servicio de Salud, Hospitales, Institutos, Centros de Diagnóstico Terapéutico, Centros de Referencia de Salud, Centros de Sangre Dirección de Atención Primaria, Consultorios y Postas Rurales. El director del Servicio de Salud podrá disponer de modo fundado que los Centros de Diagnóstico Terapéutico, los Centros de Referencia de Salud y los Centros de Sangre se consideren como un solo establecimiento al que se encuentre adosados. En igual forma procederá respecto de los consultorios y postas rurales del respectivo Servicio de Salud, con el Departamento de Atención Primaria o si corresponde establecimientos bajo dependencia administrativa.

6°. **DISPÓNGASE** que el cumplimiento de las metas específicas fijadas por los Directores de los Servicios de Salud a los establecimientos de salud de su dependencia y a la Dirección del Servicio, dará derecho a percibir, a los funcionarios que tengan la calidad de beneficiarios de las asignaciones establecidas en los artículos 83°, 84° y 85° del DFL N°1 del 2005, del Ministerio de Salud, el porcentaje respectivo del componente asociado al cumplimiento anual de metas sanitarias y al mejoramiento de la atención a los usuarios, según se indica a continuación:

- a) **En establecimientos con porcentaje de cumplimiento de las metas anuales mayor o igual a 90%:** porcentaje a pagar por el componente asociado al cumplimiento de las metas 2026, a pagar durante el año 2027:

<i>Plantas</i>	<i>Porcentaje</i>
Directivos de Carrera entre los Grados 17° y 11°	Hasta 7,5%
Profesionales	Hasta 7,5%
Técnicos	Hasta 11,5%
Administrativos	Hasta 11,5%
Auxiliares	Hasta 11,5%

- b) **En establecimientos con porcentaje de cumplimiento de las metas anuales mayor o igual a 75% y menor a 90%:** porcentaje a pagar por el componente asociado al cumplimiento de las metas 2026, a pagar durante el año 2027:

<i>Plantas</i>	<i>Porcentaje</i>
Directivos de Carrera entre los Grados 17° y 11°	Hasta 3,75%
Profesionales	Hasta 3,75%
Técnicos	Hasta 5,75%
Administrativos	Hasta 5,75%
Auxiliares	Hasta 5,75%

- c) **En establecimientos con porcentaje de cumplimiento de las metas anuales menor a 75%:** porcentaje a pagar por el componente asociado al cumplimiento de las metas 2026, a pagar durante el año 2027 es igual a 0%.

El porcentaje de cumplimiento global que determine el tramo respectivo del establecimiento se calculará multiplicando el porcentaje de cumplimiento de cada indicador por la ponderación asignada, sumándose luego, cada uno de los resultados parciales. El cumplimiento global con decimales iguales y superior a cinco deberán ser redondeados al número superior directo. La sumatoria de los resultados parciales solo debe incluir aquellos resultados en que el porcentaje de cumplimiento de cada meta específica sea mayor o igual al 60%.

8° **FACÚLTESE** a los Servicios de Salud para justificar el incumplimiento de los indicadores comprometidos, por motivos de causa externa, conforme a lo prescrito en el Artículo 45 del Código Civil. El análisis de causa externa que se invoque por un Servicio de Salud para justificar el incumplimiento de un objetivo de gestión se realizará en función del mérito de cada caso, debiendo estar fundamentado el efecto que el factor externo tiene en dicho incumplimiento. Asimismo, se deberá cuantificar la incidencia del factor externo, o efectuar una aproximación, si aquello no fuere factible. Sólo se considerará en el análisis del incumplimiento de un objetivo de gestión, la existencia de causa externa calificada y no prevista que limiten seriamente el logro de los objetivos de gestión, tales como hechos fortuitos comprobables, pandemia, catástrofe y cambios de legislación, como también las reducciones presupuestarias externas al Ministerio de Salud, siempre que afecten ítems relevantes para el cumplimiento.

9° **DÉJASE** establecido que, la periodicidad de monitoreo definida en las fichas de los indicadores propuestos en esta resolución no será un requisito para el cumplimiento en su evaluación anual, sino que una buena práctica para el seguimiento al cumplimiento.

10°. **REMÍTANSE** por el Departamento de Control de Gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los referentes técnicos de las divisiones de esta Subsecretaría, las orientaciones técnicas, certificaciones y especificaciones necesarias para el correcto monitoreo y el cumplimiento de las referidas metas.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



DRA. CARMEN ARAVENA CERDA
SUBSECRETARIA (S) DE REDES ASISTENCIALES

Distribución:

- ☒ Directores/as de Servicios de Salud del País
- ☒ SEREMIS de Salud del País.
- ☒ Subdirectores/as de Recursos Humanos, Servicios de Salud del país.
- ☒ Gabinete Sr. Ministro.
- ☒ Gabinete Sr. Subsecretaria de Salud Pública.
- ☒ Gabinete Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales
- ☒ División de Gestión de Redes Asistenciales.
- ☒ División de Atención Primaria
- ☒ División de Gestión y Desarrollo de las Personas.
- ☒ División Jurídica.
- ☒ Oficina de Partes MINSAL.
- ☒ Oficina de Partes MINSAL.